

Otite média aguda · critérios e ATB

OMA = início agudo + sinais de efusão + inflamação/otalgia. Nem todo caso precisa ATB imediato — idade, gravidade e bilateralidade decidem.

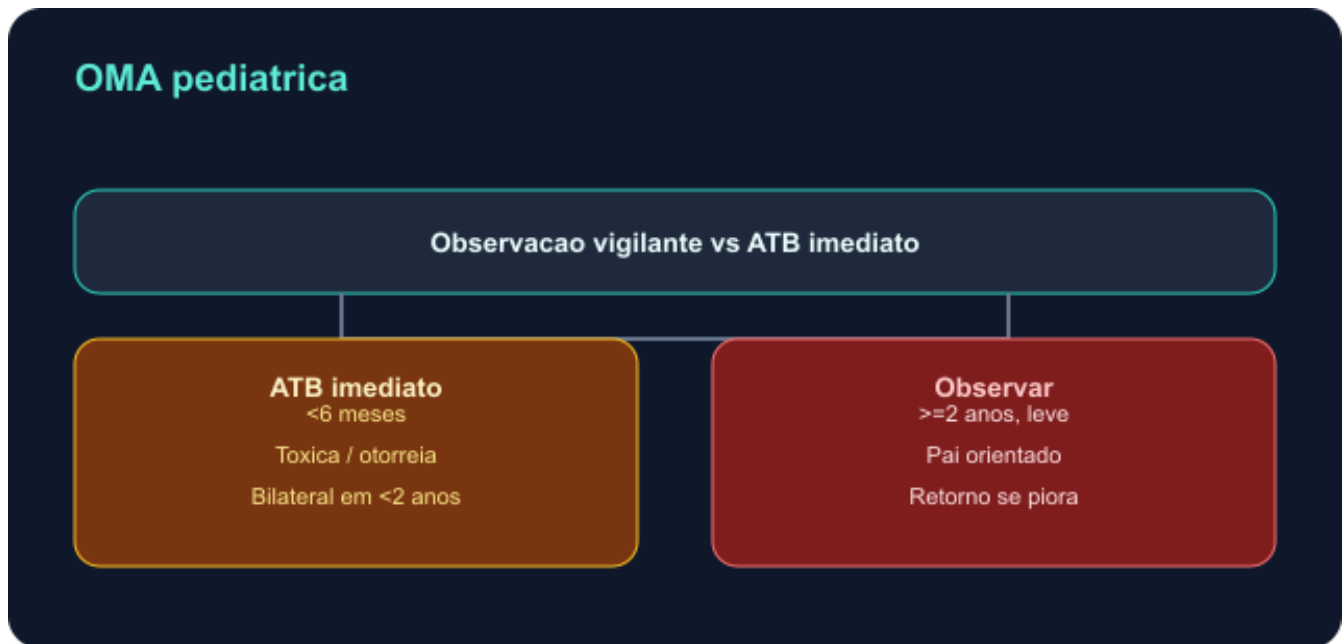
Primeira escolha

Lembre - Primeira escolha

Amoxicilina em dose alta (80–90 mg/kg/dia). Se falha ou uso recente: amoxicilina-clavulanato.

Analgesia com dipirona/ibuprofeno é parte do tratamento.

Criança tóxica, <6 meses ou OMA bilateral grave !' ATB; muitos "e2 anos leves podem observar 48–72 h.



Pontos clínicos

- Otoscopia: abaulamento, opacidade, mobilidade reduzida, hiperemia
- Não diagnosticar só por 'tímpano vermelho' em criança chorando
- Otorreia em otorragia/tubo: tratar como OMA com drenagem
- Recorrência: investigar creche, fumo passivo, adenoides; critérios de tubo de ventilação

Diagnósticos diferenciais

Condição | Pista

OMA | Abaulamento + otalgia aguda

Otite externa | Dor ao tragar pavilhão / conduto

OME (secretora) | Efusão sem inflamação aguda

Mastoidite | Protrusão de orelha, febre, toxicidade

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Mastoidite aguda é emergência ORL — não prolongue ATB oral se houver deslocamento do pavilhão, edema retroauricular e toxemia.